جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) *

طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : سناء محمود احمد عيد
المحافظة : القاهره **الحي / المدينة :** عين شمس **العنوان :** ~~
رقم البطاقة : 25912220100247 **رقم التليفون :** 01002625119 **تاريخ تسجيل الإستمارة :** 17-10-2026
العمر(تاريخ الميلاد) : 22-12-1959 **المهنة :** بدون عمل

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحه-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي **المقر بما فيه**
التوقيع:(----------) **التوقيع:**(----------)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)
نتائج الأبحاث : (مرفق)
التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)
خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي العلاج المساعد لوقاية العظام للمرضي الذين يتلقوا علاج هرموني حمض الزيلودرونيك [14157] **قسم العلاج :** الاورام
التعليق على التشخيص : ----------

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/ندى حسن **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------
الاسم: د/نرمين رمضان **الوظيفة:** ---------- **التوقيع:** ----------

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.
كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.

تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير المستشفي.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفي قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

ا.د/ ---------- **ا.د/** ---------- **د/** ---------- **د/** ----------

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : ----------
خطة العلاج : ----------
المستشفي : ----------**قسم :** ----------
جهة العلاج : ----------**نفقات :** ----------
ملاحظات : ----------

رئيس	مدير عام	ختم
المجلس الطبي المتخصص	مديرية الشئون الصحية	شعار الجمهورية

Name: سناء محمود احمد عبد
National ID: 25912220100247

تقرير طبي

السيد

تحية طيبة وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	**بشأن تقرير طبي للمريض**
بقسم:	**رقم طبي:**

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريرا عن حالته

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	**تاريخ وساعة الخروج :** PM 01:17 05-07-2026

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انة

المريضة تعاني من ورم غير حميد بالثدى و تحتاج الي **Zoledronic acid for bone protection during hormonal therapy**

التاريخ : **05-07-2026**	**الوقت :** **-- --:--**
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



زوجة

مطابقة بالصور والوصف
بدون صيغة



National ID – Front & Back
[[DOCTYPE:ID_FRONT_BACK]]

GUSTAVE ROUSSY
INTERNATIONAL
EGYPT

Name: Mrs. Sanaa Mahmoud Ahmed Eid
Date: 2025-11-23

Left Digital soft tissue mammography with high resolution sonography revealed:

Clinical summary: Post right MRM & ALAND, followed by radiotherapy, routine follow up.

Findings:

Left breast.

- Heterogeneously dense breast parenchyma that may obscure small lesions. (ACR c)
- No speculations, masses, asymmetry, distortion or suspicious microcalcifications.
- Evidence of benign rounded macro-calcifications.
- Evidence of diffuse breast edema pattern in the form of thickened skin and coarsened trabeculae.
- **Ultrasound** demonstrated no solid or cystic lesions.
- Thickened skin reaching 4 mm and coarsened trabeculae.
- Normal nipple/areola complex.
- Non-specific axillary LNs.

Right mastectomy bed.

- Clear mastectomy bed with no masses or fluid collections.
- Clear right axilla. No pathological supra or infra-clavicular lymph nodes.

Conclusion: -

Left breast (BIRADS 2): Diffuse breast edema pattern and benign calcificatiuons.
Clear right mastectomy bed and axilla.

Recommendation: -

For annual follow up and cardiac consultation.

Best Regards,
DR, Amal Hegazi, M.Sc.

BIRADS classification of breast lesions according to the American College of Radiology used for breast assessment combined with recommendations:

Category & recommendations	Suspected Cancer Risk
BIRADS 0: Non-Informative study.	
BIRADS 1: Normal study, routing screening	0 %
BIRADS 2: Benign findings, routine screening	0 %
BIRADS 3: Probably benign, for close follow up.	2 %
BIRADS 4: Probably malignant, for biopsy.	50 %
A: mild suspicion.	
B: moderate suspicion.	
C: high suspicion.	
BIRADS 5: Malignant, for biopsy.	98-100%
BIRADS 6: Pathologically proven malignant	

Mammogram
[[DOCTYPE:MAMMOGRAM]]

Presidential Program for Women's Health
Ministry of Health and Population

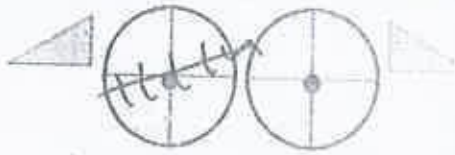
البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان

MDT form

A-Patient ID:

1- Name : شاء محمود احمد عيد Sex: Female 3- Medical number: 83148324 Old Med : 2223/2023

2-ID number: 25912220100247 Patient Age : 64 Y



Family history		Phone	01064152656	BMI		REASON OF MDT	POST OPERATIVE
marital status		NRS Score		GROUP	Cg	Date of MDT	2023-09-04
Co morbidity	CKD on dialsiysis dm hpn IHD, 3 stents	Menopausal status	POSTMENOPAUSAL				

Clinical data

Breast Imaging :

Mets Workup :

BX:	ER:	PR:	Her 2 Neu :	SISH :	Ki67 :
IDC RT	8/8	6/8	0		67

T	N	M
4B	0	

Sonomammography

RT breast UOQ MASS & micro calcifications

PATIENT HISTORY

PATHOLOGY REPORT REQUESTE DATE15/7/2023-->RT WLE AND AXLND
IDC GII ,,HIGH GRADE DCIS,,LN 4/8
FREE RESECTION MARGIN,,PT2(4cm) PN2(4/8)

MDT OUTCOME & PLAN

1- adjuvant femara
2- port

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY		RADIOLOGY	
SURGERY		PATHOLOGY	
Psychiatric		Nutrition	

MDT Form
[[DOCTYPE:MDT_FORM]]

Patient Name	: الأستاذه / سناء محمود احمد عيد	Request No.	: 13008837
Patient No.	: 25912220100247	Request Date	: 30/05/2023
Path No.	: 1658/23	Verification Date	: 14/06/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 63 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc.	:	IHC No.	:
		Registered by	: .marwa mohamed youss

IMMUNOHISTOCHEMISTRY REPORT

Clinical Data:
Right breast mass lesion

Nature of the specimen:
Tru cut biopsy collected 29-5-2023 (2:10PM)

Gross Examination:
Multiple greyish white tissue cores up to 1 cm . Totally submitted .
Sections prepared from paraffin block for immune- staining using Bench Mark ULTRA system for ER, PR,HER2, ER clone (1E2), PR clone (SP1), HER-2 clone (4B5), & Ki67 clone (30-9)

Microscopic examination:
- Histological type: Invasive duct carcinoma
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G II(3+2+1)
- Angioinvasion: Couldn't be detected in sections examined .
- Ductal carcinoma in situ: Positive
- IPT

ER: Strong nuclear reaction in 90% of tumor cells (Allred score 8/8)
PR: Strong nuclear reaction in 30% of tumor cells (Allred score 6/8)
Her-2: No membrane reaction in tumor cells (score 0)
Ki 67: 10 % nuclear reaction in tumor cells
Positive control showed appropriate reactivity

Diagnosis:
Right breast mass lesion , Tru cut biopsy:
- Invasive duct carcinoma grade II
- IPT

Verified by :
dr.esraa magdy

Immunohistochemistry
[[DOCTYPE:IHC]]

Patient Name	: الأستاذه / سناء محمود احمد عيد	Request No.	: 13000429
Patient No.	: 25912220100247	Request Date	: 15/07/2023
Path No.	: 2230/23	Verification Date	: 24/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مباشره
Age	: 63 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data: Right breast cancer. up front.
Nature of the specimen: Right WLE & ALNDs

Gross Examination:
Two specimens were received submitted as:
1-Right simple mastectomy measuring 17x12x4 cm, with skin covering; 17x5.5 cm. Cut section revealed an ill-defined firm grayish white clipped tumor bed site measuring 4x3x2.5 cm, away from deep margin by 3 cm and 2 cm from skin.
2- Axilla measured 5x3 cm. repeated careful dissection revealed only another 4 nodes. ranging in size from 0.5 cm to 1 cm.
• Frozen section: Positive sentinel lymph nodes (3/4).

Microscopic examination:
• Histological type: Invasive duct carcinoma, GII
• Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G (3+3+1)
• Angioinvasion: yes
• Ductal carcinoma in situ: yes (20% High grade)
o Skin involvement: No , Free nipple & areola.
• Lymph node involvement: Yes, Positive metastatic deposits in 4 nodes (4/8)
• Resection Margins: Free
• Histologic response to therapy: N/A
• Additional pathologic findings: Microcalcification.

Diagnosis:
Right breast cancer, Right WLE & ALNDs;
Invasive duct carcinoma, GII
20 % High grade DCIS.
LNs : Positive (4/8).

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Patient Name	: الأستاذه / سناء محمود احمد عيد	Request No.	: 13000429
Patient No.	: 25912220100247	Request Date	: 15/07/2023
Path No.	: 2230/23	Verification Date	: 24/08/2023
Sex	: Female	Financial Category	: اورام دار السلام - مبادره
Age	: 63 Y	Department	: Out Patient
Referreing Doc	:	Registered by	: .marwa mohamed youss

Pathology Report

Free resection margins.
Free Nipple & areola.
Stage: pT2 pN2 .

Prof. Gamal Abdelaty Dr. Marwa Mahmoud

Verified by :
Dr.Marwa mahmoud

Room No. (4) - First Floor Building No. 267- Nile Corniche - Sitte El Qadema - Cairo, Egypt

Pathology Report
[[DOCTYPE:PATHOLOGY_REPORT]]

Name : Sanaa Mahmoud
Date : Thursday, May 25, 2023

- Liver :

Average size Bright liver normal shape and uniform echo pattern smooth surface . No focal lesion or dilated intrahepatic biliary radicles. Main portal vein is not dilated Dilated CBD 12 mm

- Gall bladder

Normal shape, average size and wall thickness. No calculi or mud are seen in supine or right lateral position.

- Spleen

Average size and homogenous texture no focal lesion splenic vein not dilated.

- Panereas:

concealed by gases

- Kidneys;

both of normal shape, average size and parenchymal thickness. No cysts, calculi or ba pressure changes. Bilateral Renal Gravels

- Pelvis :

Normal urinary bladder wall no stones or masses

No Ascites

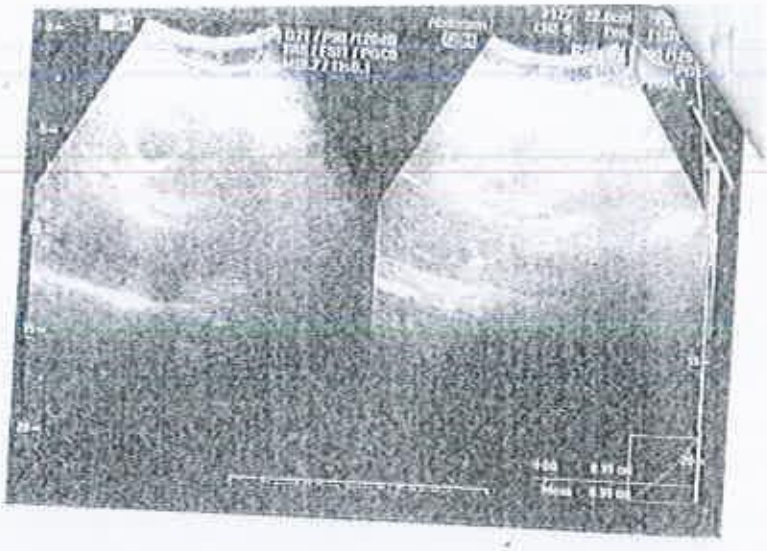
Conclusion :

- Bright liver Dilated CBD 12 mm for correlation with MRCP
- Bilateral Renal Gravels
- Colonic gaseous distension

Signature
Dr Waleed El Nabwey MD

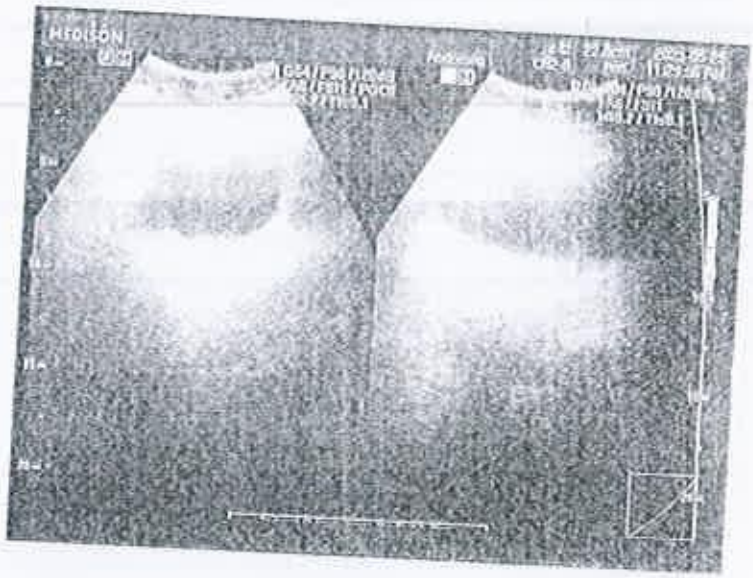
CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]

Name : Sanaa Mahmoud
Date : Thursday, May 25, 2023



- **Liver :**

Average size Bright liver normal sh
No focal lesion or dilated intrahepati
Dilated CBD 12 mm



- **Gall bladder**

Normal shape, average size and w
supine or right lateral position

- **Spleen**

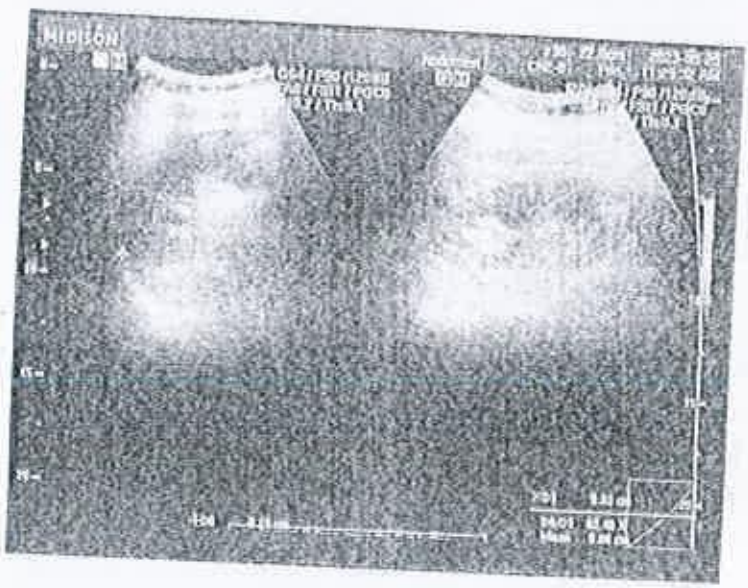
Average size and homogenous text

- **Panereas:**

concealed by gases

- **Kidneys:**

both of normal shape, average size a
pressure changes. Bilateral Renal Gr



- **Pelvis :**

Normal urinary bladder wall no

No Ascites

Conclusion :

- Bright liver Dilated CBD 1
- Bilateral Renal Gravels
- Colonic gaseous disten



CT Scan
[[DOCTYPE:CT_SCAN]]